

角度分析,在治疗鼻咽癌放疗引起的口腔黏膜炎时可选用效价比较高的复方维生素 B₁₂。

[参考文献]

[1] 谷铎之,殷蔚伯,刘泰福,等.肿瘤放射治疗学[M].第2版.北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1993.443—452.

[2] 张天泽.中国常见恶性肿瘤诊治规范 鼻咽癌分册[M].第2版.北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版

社,1991.54.

[3] 陈洁.药物经济学[M].成都:成都科技大学出版社,2000.96.

[4] 许筱,周云芳,叶菊芬.氧氟沙星与氟罗沙星治疗下呼吸道感染的治疗与药物经济学分析[J].医药导报,2004,23(7):507.

[5] 周元瑶.药物流行病学[M].北京:中国医药科技出版社,1996.248—254.

老年患者药物相互作用的特点及其对策

张敏华

(浙江省嘉善县中医医院药剂科, 314100)

[摘要] 随着老龄化社会的到来,老年患者的用药问题应引起足够的重视。老年患者由于生理功能的变化,药动学亦发生相应变化。另外,由于老年患者常罹患多种疾病而同时使用多种药物进行治疗,容易引起老年患者体内的药物相互作用。医师和药师在临床实践中应注意及时发现和解决不良的药物相互作用和因此引起的药物不良反应。

[关键词] 药物不良反应;药物相互作用;老年患者;合理用药

[中图分类号] R969.2;R969.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-0781(2005)08-0735-02

随着我国人均寿命的延长,社会人口老龄化趋势正逐渐显现。老年人由于体质下降,容易罹患多种疾病。临床上,由于老年患者同时存在多种疾病,联合应用多种药物治疗的情况非常普遍。这使得药物相互作用在这一特殊人群成为一个突出的问题。临床实践中药师在对处方进行监督检查以及对患者进行用药指导时,对上述问题应引起足够的重视。笔者在本文中结合自己的临床实践就以上问题进行探讨。

1 老年患者的疾病和药物代谢特征

老年患者的疾病症状常很少起源于单一疾病。因此在用药时应注意针对多种病因,还应注意多种药物间的相互作用。临床上为减轻药物的不良反应,常联合使用较小剂量的两种或两种以上的药物。但对于老年患者,合用药物导致的相乘相加效果可能会很难预料。一般老年患者在出现药物不良反应时,常难以找到导致不良反应的药物。在临床实践中,老年患者常因患多种疾病而需不同科室的医生开药。因此药师有必要综合考察多张处方,避免重复使用同类药或同效药,并注意明显的配伍禁忌。有时药师需要获取患者完整的病历及药历。

随着年龄的增长,老年患者的药动学发生变化,由于老年患者代偿能力低下,正常剂量或相对较小剂量的药物亦可能诱发不良反应。老年患者的生理和药物代谢主要有以下变化:药物吸收面积下降,内脏血液循环减慢,胃液 pH 值升高,消化道运动发生变化,体内水含量下降,肌肉萎缩,血清清蛋白含量下降,体内脂肪含量升高,肝脏血流量减少,肝脏酶活性下降,酶诱导作用减弱,肾脏血流量减少,肾小球滤过率降低,肾小管分

泌功能降低,药物受体数量减少,受体亲和力下降等。同类或不良反应类似的药物合用,更容易导致老年患者发生药物不良反应。因此除应对老年患者进行血药浓度监测外,严密监测患者的临床表现(包括症状和体征)也是必要的。

由于代偿能力下降,在普通人群中很少发生或不会发生的药物不良反应或药物相互作用也会在老年患者中发生。如对正在服用利尿药的老年男性患者加用 α 受体阻滞药以治疗前列腺肥大,利尿药导致的多尿症状可能会更加显著,由于患者频繁如厕可能导致功能性尿失禁。另外,老年患者常自行使用一些非正式治疗,如服用民间方药、特殊食品及各种营养保健品等。这种情况下,药物的相互作用常很难评价。因此药师还应和老年患者加强交流^[1]。

2 老年患者药物相互作用的预防对策

当怀疑老年患者体内存在药物相互作用时,应该评价该相互作用是否会引起药物不良反应。早期发现即可停止使用致不良反应药物。对患者进行用药知识教育是非常重要的。老年患者由于知识水平所限和理解能力低等原因,常不能很好地接受教育,达不到有效自我管理用药的目的。因此,对患者的亲友或照顾患者的人进行健康教育也很重要。

药师应评价患者使用的药物是否存在相互作用及可能导致的不良反应。根据经验,笔者推荐中医望、闻、问、切的四诊法。除对患者进行询问(问诊)及身体检查(切诊)外,医师和药师还可以通过观察来收集药物相互作用导致不良反应的信息。笔者建议医师和药师应对老年患者观察和询问以下内容:来药房时注意患者问候、声音、会话(包括词汇、语法和逻辑),递上处方时注意患者的呼气气味、有无震颤、手及指甲异常,观察患者等待发药期间的行姿、坐姿(包括是否安静),呼患者姓名时注意患者的听力和起立姿势,解释服药说明时注意患者的视

[收稿日期] 2004-09-24 **[修回日期]** 2004-10-30

[作者简介] 张敏华(1975—),女,浙江嘉善人,药师,学士,主要从事医院药学工作。电话:0573-4222252-8103, E-mail 4120200@163.com.

力、听力、记忆力和理解能力,递送药物时,注意患者的整理能力、视力、关节活动情况等。此外,医师除对处方上药物之间可能的相互作用进行评估外,对患者自行服用的非处方药、营养保健品、烟、酒等也需确认。另外,笔者建议对老年患者建立个人药历,将一些重要的项目如重要检查结果、主要疾病诊断结果、正在服用的药物(包括处方药和非处方药)、保健品及重要的生活习惯如饮食习惯、嗜好(如烟、酒等)等信息均记入药历。

在对老年患者所用的治疗药物进行药物相互作用评价时,还应对应治疗方法进行评价。应尽量避免用多种药物治疗同一种疾病,而应提倡用一种药物治疗多种疾病。对使用目的不明

确的药物,有必要与医师联系加以确认。决定老年患者的给药剂量时,不能仅参照药物使用说明书推荐的剂量,而应参照该药在老年人群使用情况的研究文献。在没有这些信息时,通常先给予低剂量,再根据患者的反应,逐渐调整剂量。药效与不良反应评价亦不能仅依据血药浓度监测结果,患者的症状和体征也是非常重要的参考依据。

[参考文献]

- [1] Kane R L, Ouslander J G, Abrass I B. Essentials of clinical geriatrics [M]. 4th ed. London: McGraw Hill Press, 1999. 390.

两种葡萄球菌耐药性的变迁

郭晨雯, 范 春, 王京鹰, 傅金英
(山东省青岛市人民医院药剂科, 266001)

[摘要] 目的 研究 5 a 内医院内金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌耐药性的变迁。方法 采用回顾性分析方法, 对 1999 年 1 月~2003 年 12 月分离得到的 187 株金黄色葡萄球菌和 242 株表皮葡萄球菌的耐药性进行分析。药敏试验采用 K-B 纸片扩散法。结果 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐甲氧西林表皮葡萄球菌(MRSE)的分离率逐年增高, 5 a 总分离率分别为 67.38% 和 66.12%; 从呼吸道分离的金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌最多; 表皮葡萄球菌的耐药率略低于金黄色葡萄球菌, 但其感染率有超过金黄色葡萄球菌的趋势。结论 MRSA 和 MRSE 对大部分抗菌药物均已高度耐药, 对万古霉素依然高度敏感。临床合理用药水平亟待提高。

[关键词] 金黄色葡萄球菌; 耐甲氧西林; 表皮葡萄球菌; 耐甲氧西林; 耐药菌株

[中图分类号] R969.3; R978

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-0781(2005)08-0736-02

近年来,葡萄球菌已成为医院内感染的常见病原菌,尤其是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐甲氧西林表皮葡萄球菌(MRSE)感染有逐年增加的趋势^[1]。为了解我院葡萄球菌医院内感染现状,笔者对我院 1999 年 1 月~2003 年 12 月的住院患者中分离出的 242 株表皮葡萄球菌和 187 株金黄色葡萄球菌的耐药性进行了分析,以便确定我院医院内感染葡萄球菌的耐药性。

1 材料与方法

1.1 材料 被检材料均为我院住院患者留取的痰、尿、血、脓性分泌物等标本,共分离出 187 株金黄色葡萄球菌和 242 株表皮葡萄球菌,菌种按《全国临床检验操作规程》进行种属鉴定。

1.2 药物敏感试验方法 采用 K-B 纸片扩散法,药敏纸片和 M-H 培养基均由杭州天和微生物试剂有限公司提供。纸片扩散法与判定标准参照美国国家临床实验室标准委员会(NCCLS)1999 年确定的标准。标准菌株 ATCC25923(金黄色葡萄球菌)和 ATCC040188(表皮葡萄球菌)作药敏质控。

1.3 MRSA 和 MRSE 的鉴定 将药敏试验中耐苯唑西林(每片 1 μg)的菌株(抑菌环直径 ≤ 10 mm)做适度稀释,调整菌量为 0.5 麦氏单位,接种于含 6 μg·mL⁻¹苯唑西林和 4% 氯化钠的

BBL 培养基上,经 35℃ 培养 24 h 生长者即为 MRSA; 在含 4% 氯化钠的 M-H 琼脂平皿上,35℃ 条件下培养 24 h 后,1 μg 苯唑西林纸片抑菌环直径 ≤ 17 mm 所得到的表皮葡萄球菌判为 MRSE。

1.4 统计学方法 用 WHONET5 软件对葡萄球菌临床分离株进行耐药性分析,耐药率间的显著性比较用 χ^2 检验。

2 结果

2.1 两种葡萄球菌的分离情况 1999~2003 年,MRSA 各年分离率分别为 61.29%, 64.28%, 69.04%, 70.97% 和 72.50%, MRSA 5 a 的总分离率为 67.38%; 1999~2003 年,MRSE 各年分离率分别为 44.83%, 63.26%, 70.69%, 75.68% 和 85.00%, MRSE 5 a 的总分离率为 66.12%。从各年分离率看,两种葡萄球菌的分离率均呈逐年上升趋势。且自 2001 年起分离率明显升高,与 1999 年相比较,2001、2002、2003 年 MRSE 的分离率均明显升高,且均差异有极显著性(均 $P < 0.01$)。

2.2 两种葡萄球菌的耐药情况 总体上看,MRSA 与 MRSE 耐药情况基本相似,两菌对青霉素类药物(如青霉素、氨苄西林)、庆大霉素、诺氟沙星和红霉素均高度耐药,对头孢菌素类药物和环丙沙星也表现出较高的耐药率,对万古霉素均高度敏感。MRSA 对氨苄西林-舒巴坦的耐药率明显高于 MRSE,差异有显著性($P < 0.05$)。甲氧西林敏感表皮葡萄球菌(MSSE)和甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌(MSSA)对常用抗菌药的耐药情况不同,MSSA 对抗菌药物的耐药率高于 MSSE。MSSA 和 MSSE 对

[收稿日期] 2004-12-14

[修回日期] 2005-01-10

[作者简介] 郭晨雯(1952—),女,山东青岛人,副主任药师,学士,主要从事医院药学工作。电话:0532-82828289。